H- LES TUMEURS NEURO-ENDOCRINES DIGESTIVES

Etoposide-Cisplatine J1 à J3 J1=J22. [1]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Doses	Voie	Observation
J1					
1	Pré-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0,9% 2L en 6h ou SG 5% 2L + 4gNacl et 2gKcl en 6h
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en 2h puis rinçage
J2					
1	Pré-médication	Aprepitant	125.0 mg	Orale	Un comprimé 45min avant chimiothérapie
2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en 2h puis rinçage
5	Chimiothérapie	Cisplatine	100.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SS 0,9% en 2h J2 (ou J1)
6	Post-hydratation	Chlorure De Sodium	2000.0 ml	Intraveineuse	SS 0,9% 1L en 4h ou SG 5% 1L + 4gNacl et 2gKcl en 4h
J3					
1	Pré-médication	Aprepitant	80.0 mg	Orale	Un comprimé 45min avant chimiothérapie

2	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
4	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en 2h puis rinçage

[1] Mitry E, Baudin E, Ducreux M, Sabourin JC, Rufié P, Aparicio T, et al. Treatment of poorly differentiated neuroendocrine tumours with etoposide and cisplatin. Br J Cancer 1999; 81:1351–1355.

Etoposide-Carboplatine J1 à J3 J1=J22. [2]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SS 0,9% puis rinçage (J1 J2 J3)
4	Chimiothérapie	Carboplatine	AUC 5.0	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
J2					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie

3	Etoposide	100.0 Mg/M2	Intraveineuse	Chimiothérapie	Dans 500 ml de SS 0,9% puis rinçage (J1 J2 J3)
J3					
1	Pré-Médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-Médication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Etoposide	100.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SS 0,9% puis rinçage (J1 J2 J3)

[2] Sorbye H, Welin S, Langer SW, Vestermark LW, Holt N, Osterlund P, et al. Predictive and prognostic factors for treatment and survival in 305 patients with advanced gastrointestinal neuroendocrine carcinoma (WHO G3): the NORDIC NEC study. Ann Oncol 2013; 24:152–160.

Capecitabine-Temozolomide = CAPTEM / TEMCAP J1=J29. [3]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
J1					
1	Chimiothérapie	Capecitabine	1500.0 mg/m2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J
J10					
1	Chimiothérapie	Temozolomide	200.0 mg/M2	Orale	Le soir au coucher de J10 à J14

[3] Strosberg JR, Fine RL, Choi J, Nasir A, Coppola D, Chen D-T, et al. First-line chemotherapy with capecitabine and temozolomide in patients with metastatic pancreatic endocrine carcinomas. Cancer 2011; 117:268–275.

FOLFIRI J1=J15. [4]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-medication	Methylprednisolone	120 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-medication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-medication	Atropine	0.5 mg	Sous-cutanée	Durant la perfusion d'Irinotecan
4	Chimiothérapie	Irinotecan	180.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'acide folinique en 90 min puis rinçage SG
5	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'Irinotécan en 2h puis rinçage SG
6	Chimiothérapie	5-Fluorouracil	400.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 100 ml de SG 5% en bolus en 10 min
7	Chimiothérapie	5-Fluorouracil	2400.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[4] Hentic O, Hammel P, Couvelard A, Rebours V, Zappa M, Palazzo M, et al. FOLFIRI regimen: an effective second-line chemotherapy after failure of etoposide-platinum combination in patients with neuroendocrine carcinomas grade 3. Endocr Relat Cancer 2012; 19:751–757.

FOLFOX J1=J15. [5]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-medication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-medication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	85.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'acide folinique puis rinçage SG
3	Chimiothérapie	Acide Folique	400.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en Y de l'oxaliplatine puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 100 ml de SG 5% en bolus
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable

[5] Hadoux J, Malka D, Planchard D, Scoazec JY, Caramella C, Guigay J, et al. Post-first-line FOLFOX chemotherapy for grade 3 neuroendocrine carcinoma. Endocr Relat Cancer 2015; 22:289–298

CAPIRI J1=J22. [6,7]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-medication	Methylprednisolone	120 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-medication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Pré-medication	Atropine	0.5 mg	Sous-cutanée	Durant la perfusion d'Irinotecan

4	Chimiothérapie	Irinotecan	250.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SS 0.9% en 90 min en Y de l'acide folinique
5	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/m2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J (Première dose le soir de J1)

[6] Sorbye H, Strosberg J, Baudin E, Klimstra DS, Yao JC. Gastroenteropancreatic high-grade neuroendocrine carcinoma. Cancer 2014; 120:2814–2823.

[7] Garcia-Carbonero R, Sorbye H, Baudin E, Raymond E, Wiedenmann B, Niederle B, et al. ENETS Consensus Guidelines for High-Grade Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors and Neuroendocrine Carcinomas. Neuroendocrinology 2016; 103:186–194.

CAPOX J1=J22. [6,7]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Pré-medication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-medication	Ondansetron	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimiothérapie	Oxaliplatine	130.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% en 120 min
4	Chimiothérapie	Capacitabine	2000.0 mg/m2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J (Première dose le soir de J1)

[6] Sorbye H, Strosberg J, Baudin E, Klimstra DS, Yao JC. Gastroenteropancreatic high-grade neuroendocrine carcinoma. Cancer 2014; 120:2814–2823.

[7] Garcia-Carbonero R, Sorbye H, Baudin E, Raymond E, Wiedenmann B, Niederle B, et al. ENETS Consensus Guidelines for High-Grade Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors and Neuroendocrine Carcinomas. Neuroendocrinology 2016; 103:186–194.

5FU-Dacarbazine J1 à J2 J1=J22. [8]

Ordre	Type	Produit/Protocole	Doses	Voie	Observation
J1					
1	Pré-médication	Methylprednisolone	120.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
2	Pré-medication	Pré-Médication	8.0 mg	Intraveineuse	IVL 30min avant chimiothérapie
3	Chimitohérapie	Acide Folique	400.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage SG
4	Chimiothérapie	Dacarbazine	400.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage
5	Chimiothérapie	Fluorouracil	400.0 mg/ m2	Intraveineuse	Dans 100 ml de SG 5% en bolus
6	Chimiothérapie	Fluorouracil	2400.0 mg/m2	Intraveineuse	Dans SG 5% en perfusion continue de 48 h sur diffuseur portable
J2					
1	Chimiothérapie	Dacarbazine	400.0 mg/ M2	Intraveineuse	Dans 500 ml de SG 5% puis rinçage

[8] de Mestier L, Walter T, Brixi H, Evrard C, Legoux J-L, de Boissieu P, et al. Comparison of Temozolomide-Capecitabine to 5-Fluorouracile-Dacarbazine in 247 Patients with Advanced Digestive Neuroendocrine Tumors Using Propensity Score Analyses. Neuroendocrinology 2019; 108:343–353.

Capecitabine - Bevacizumab J1=J22. [9]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Bevacizumab	7.5 mg/Kg	Intraveineuse	90 min Première Cure puis 60 min Cures Suivantes, TA et BU avant Bevacizumab, TA après Bevacizumab
2	Chimiothérapie	Capecitabine	2000.0 mg/ m2	Orale	2x/jour : Matin et soir 30min après le repas, pdt 14J

[9] Mitry E, Walter T, Baudin E, Kurtz J-E, Ruszniewski P, Dominguez-Tinajero S, et al. Bevacizumab plus capecitabine in patients with progressive advanced well-differentiated neuroendocrine tumors of the gastro-intestinal (GI-NETs) tract (BETTER trial) – A phase II non-randomised trial. European Journal of Cancer 2014; 50:3107–3115

Sunitinib en continu. [10]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Thérapie ciblée	Sunitinib	37.5 mg	Orale	Un Cp par jour 1 h avant repas ou 2h après repas x 30 j en continu

[10] Raymond E, Dahan L, Raoul J-L, Bang Y-J, Borbath I, Lombard-Bohas C, et al. Sunitinib malate for the treatment of pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011; 364:501–513.

Everolimus en continu. [11]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Therapie ciblée	Everolimus	10.0 mg	Orale	Un Cp de 10 mg ou 2 Cp de 5 mg par jour 1 h avant repas ou 2h après repas x 30 j en continu

[11] Yao JC, Shah MH, Ito T, Bohas CL, Wolin EM, Van Cutsem E, et al. Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011; 364:514–523.

Lanreotide LP [12]

Ordre	Type	Produit / Protocole	Dose	Voie	Observation
1	Hormonothérapie	Lanreotide	120.0 Mg	Sous Cutanée	Sous Cutanée Profonde

[12] Caplin ME, Pavel M, Ćwikła JB, Phan AT, Raderer M, Sedláčková E, et al. Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2014; 371:224–233.